

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient's Copy Cholecystectomy – Open

معلومات الإقرار – نسخة المريض استئصال المرارة-بالجراحة المفتوحة

1. What is an open cholecystectomy?

A cholecystectomy is the removal of the gall bladder through a cut on the right side of the abdomen.

Sometimes during surgery an examination of the bile duct is required to look for gallstones. To do this a Contrast medium is injected and x-rays are taken of the bile duct.

2. My anaesthetic

This procedure will require an anaesthetic.

See **About Your Anaesthetic information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this

procedure. They include but are not limited to the following:

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.

1- ما هو استئصال المرارة بالجراحة المفتوحة؟

هو إزالة المرارة عن طريق شق جراحي في الجانب الأيمن من البطن.

أحياناً واثناء الجراحة ، قد تظهر حاجة لفحص القناة المرارية بحثاً عند حصوات المرارة . وللقيام بذلك يتم حقن مادة وسط متباين مع أخذ صور بالأشعة السينية للقناة المرارية.

2-التخدير الذي أتلقيه

سوف يتطلب هذا الإجراء الخضوع للتخدير .

اقرأ تعليمات التخدير المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج. إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها.

ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

مخاطر عامة:

- قد يحدث التهاب ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى
- قد يحدث نزيف مما قد يتطلب إعادتك مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً إذا كنت ممن يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل(بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول(بيرسانتن أو اساسانتن)
- قد يحدث إنسداد للشعب الهوائية الصغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر ، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي(الفيزيائي)

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Deep bleeding in the abdominal cavity could occur and this may need fluid replacement or further surgery.
- Some stones may be found outside the gall bladder in the ducts, which may need further surgical treatment.
- Damage may occur to the bile ducts near the liver and gall bladder with long term problems with blockage.
- Difficulty passing urine after the operation and may need a catheter passed into the bladder.
- In some people, healing of the wound may be abnormal and the wound can be thickened and red and the scar may be painful.
- Infections such as pus collections can occur in the abdominal cavity. This may need surgical drainage.
- A weakness can occur in the wound with the development of a hernia.
- Adhesions (bands of scar tissue) may form and cause bowel obstruction. This can be a short term or a long term complication and may need further surgery.
- Persistent intolerance to fatty foods may occur after the procedure, which can cause loose bowel motions (diarrhoea) and flatulence.
- An allergic reaction to the injected Contrast is rare.

- للصدر.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة ، تزداد مخاطر الإصابة بالتهاب الجرح والصدر مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مم يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة متعلقة بهذا الإجراء:

- نزيف عميق في التجويف البطني قد يستدعي إعطاء سوائل لتعويض الدم المفقود أو جراحة أخرى.
- وجود بعض الحصوات خارج الحويصلة المرارية في القنوات المرارية. قد تظهر الحاجة لجراحة أخرى .
- حدوث ضرر للقنوات المرارية بالقرب من الكبد والحويصلة المرارية مسبباً مشكلات طويلة الأمد من الانسداد.
- قد تكون هناك صعوبة في إدرار البول بعد الجراحة ، مما قد يتطلب وضع أنبوب (قسطرة بولية) في المثانة .
- الإصابة بالتهاب في سوائل البطن كتجمعات للصدى في التجويف البطني مما قد يتطلب تفريغ الصديد جراحياً .
- عند بعض المرضى ، يحدث التئام الجرح بشكل غير طبيعي. قد تزداد سماكة الجرح ويصبح لونه أحمر وقد يكون مؤلماً.
- قد تحدث التصاقات (أحزمة من الأنسجة المتندبة) وتسبب انسداداً للأمعاء. قد يحدث ذلك على المدى القريب أو البعيد وقد يحتاج حلاً جراحياً.
- ضعف في موقع الجرح مما يؤدي إلى نشوء فتق .
- عدم القدرة على تحمل وتناول الأطعمة الدهنية. قد يظهر بعد الجراحة ويكون بشكل مستمر مسبباً الإسهال وخروج الغازات
- من النادر حدوث تفاعل تحسسي من مادة الصبغة المستخدمة في الأشعة.



المركز الطبي الدولي
International Medical Center

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Notes to talk to my doctor about:

أمور أتناقش حولها مع طبيبي:
